

정위성 신방광(orthotopic neobladder)은 환자 본인의 장 일부로 만든 새 방광으로, 요도에 연결되어 주머니(백) 없이 자연스럽게 소변을 볼 수 있게 합니다. 잘 비우는 데 적응하고 조절력을 회복하려면 시간과 연습이 필요합니다.

이 수술에 대하여

소장 약 **40–60cm**를 열어 저압 저장낭으로 접고 **요도**에 연결합니다. 신장에서 내려오는 요관도 저장낭에 연결됩니다. **스토마(장루)**와 **백**은 필요하지 않습니다.

신방광은 장으로 만들기 때문에 “지금 당장” 신호를 느낄 수 없습니다. 따라서 다음을 익혀야 합니다:

- **정해진 시간에** 골반저를 이완하여 소변보기 — **밤에 일어나서도** 시행합니다.
- 완전히 비워지지 않을 때 도뇨관으로 배출(여성에게 더 흔함).
- **골반저근 운동**으로 조절력 강화.

조절력은 **수개월**에 걸쳐 좋아집니다. 초기에, 특히 밤에 요실금이 있을 수 있습니다. 요도 상태, 신장 기능, 자가 관리 능력에 따라 모든 분께 적합하지 않을 수 있습니다.

안전한가요?

정위성 신방광은 가장 “자연스러운” 결과를 주는 잘 확립된 방법입니다. 요관 도뇨(도관)보다 수술이 크고 길며 더 많은 학습과 사후 관리가 필요합니다. 위험으로는 출혈·감염·누공 등 수술 합병증, 주간 또는 야간 요실금, 도뇨관 필요 여부, 점액, 요로감염, 장기적인 전해질·비타민·신장 변화(추적 관찰 필요)가 있습니다.

용어 설명

신방광(Neobladder)

장 조각으로 만든 새 방광.

정위성(Orthotopic)

정상 위치에 놓이고 요도에 연결되어 평소처럼 소변을 봄.

요도(Urethra)

소변이 몸 밖으로 나오는 관.

요관(Ureters)

신장에서 소변을 운반하는 관; 신방광으로 연결됨.

시간제 배뇨(Timed voiding)

요의를 기다리지 않고 정해진 시간에 소변 보기.

자가도뇨(Self-catheterization)

신방광이 완전히 비워지지 않을 때 얇은 관을 직접 삽입하여 배출.

골반저(Pelvic floor)

소변을 참고 배출하는 데 도움을 주는 근육.

점액(Mucus)

장이 분비하는 미끈한 액체; 소변에 섞여 나오는 것은 정상.

아픈가요? 수술은 전신마취 하에 진행되므로 수술 중에는 아무것도 느끼지 못합니다. 수술 후에는 배 쪽 통증이 있으며 장이 "깨어나기"까지 며칠이 걸립니다. 수술 후 신방광 안에 도뇨관(약 2-3주 유지)과 부드러운 스텐트가 삽입됩니다. 대부분 약 5-8일 입원하며 수술 자체는 오래 걸립니다.

준비 방법 (수술 전)

- **전신마취**로 진행 — 금식 및 혈액희석제 중단 등 모든 수술 전 지침을 따르세요. **장 세척(bowel prep)**이 필요할 수 있습니다.
- 낮과 밤 모두 **시간제 배뇨**, 필요 시 **자가도뇨**, 골반저근 운동이 필요하다는 점을 이해하세요.
- **금연**하고, 퇴원 후 도움을 줄 사람을 미리 준비하세요.

다음에 해당하면 **미리** 의료진에게 알려주세요:

- **혈액희석제** 복용 중이거나 현재 감염이 있는 경우
- **장 질환**, 신장 문제, 복부 수술 또는 방사선 치료 과거력

수술 과정

- 1 마취 후 잠들며 항생제가 투여됩니다.
- 2 장 일부를 분리하고 나머지 장을 다시 연결합니다.
- 3 분리된 장을 열어 저장낭으로 접고 요도에 봉합합니다.
- 4 요관을 저장낭에 연결하고 회복 기간 동안 도뇨관과 부드러운 스텐트를 삽입합니다.

후

- 약 **5-8일** 후 퇴원하며 **도뇨관은 약 2-3주** 유지됩니다. 점액 제거를 위해 세척이 필요할 수 있습니다.
- 도뇨관 제거 전 신방광 **치유 X선 촬영**을 시행합니다.
- 이후 **시간제 배뇨**(밤에 알람 설정), 골반저근 운동, 필요 시 **자가도뇨**를 익힙니다.
- 초기에는 요실금(특히 야간)이 있으나 수개월에 걸쳐 개선됩니다. 점액은 정상이며 충분한 수분 섭취와 평생 추적 관찰(비타민 B12 포함)이 필요합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- **소변이 나오지 않거나 도뇨관이 막혀 배출되지 않는 경우**
- 심한 복통, 구토, 또는 **가스나 대변이 전혀 나오지 않는 경우**
- 심한 출혈, 상처 발적·분비물, 또는 옆구리 통증

기억할 세 가지

1. 신방광은 장으로 만들어 요도에 연결된 새 방광으로, 백 없이 자연스럽게 소변을 봅니다.
2. 낮과 밤 모두 시간제 배뇨, 골반저근 운동, 필요 시 자가도뇨가 필요하며 조절력은 수개월에 걸쳐 향상됩니다. 초기 요실금은 정상입니다.
3. 금식·장 세척 지침을 따르고 금연하세요. 치유 X선 촬영 후 의료진이 제거할 때까지 도뇨관을 유지하고, 소변이 나오지 않거나 막히면 즉시 연락하세요.